

CSCV — Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV)

Administración: Autoaplicada

N.º de ítems: 59

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

El CSCV es un instrumento diseñado para evaluar la calidad de vida del paciente esquizofrénico tal y como éste la percibe.

Consta de 59 ítems que se agrupan en 2 escalas:

Aspectos favorables (CSCV-F): formada por 13 ítems que a su vez se agrupan en 3 factores:

- Satisfacción vital (ítems 4, 10-13).
- Autoestima (ítems 1-3, 5).
- Armonía (ítems 6-9).

Aspectos desfavorables (CSCV-D): formada por 46 ítems que se agrupan en 9 factores:

- Falta de aprehensión cognitiva (ítems 1-3, 5 y 35).
- Pérdida de energía (ítems 4, 9, 10, 18, 21, 26, 32, 34, 37 y 45).
- Falta de control interno (ítems 8, 15-17, 25, 29 y 46).
- Dificultad de expresión emocional (ítems 7, 12, 23, 28 y 40).
- Dificultad de expresión cognitiva (ítems 6, 36, 38, 41-44).
- Extrañamiento (ítems 11, 19 y 39).
- Miedo a la pérdida del control (ítems 20, 30 y 33).
- Hostilidad contenida (ítems 22, 24 y 27).
- Autoestima (ítems 13, 14 y 31).

Los ítems se puntúan mediante una escala Likert de 5 valores que oscilan entre 1 (completo desacuerdo) y

5 (completo acuerdo).

El marco de referencia temporal es el momento actual.

Es una escala autoaplicada.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Proporciona un perfil de calidad de vida, con puntuaciones en los 12 factores y en las 2 escalas.

La puntuación en cada factor se halla calculando la media aritmética de los puntos en los ítems que lo forman. La

puntuación en las escalas se halla calculando la media aritmética de las puntuaciones en los factores que las conforman.

Todas las puntuaciones que se obtienen oscilan entre 1 y 5. No existen puntos de corte:

En los factores de la escala desfavorable y en ella misma: a mayor puntuación, peor calidad de vida.

En los factores de la escala favorable y en ella misma: a mayor puntuación, mejor calidad de vida.

Fuente: Desarrollo del Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV). Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr Cienc Afines 1997; 25 (Supl 2): 11-23